

sunate, y compris au cours du premier trimestre de leur grossesse, en cas d'accès grave, compte tenu de la particulière gravité du paludisme sur ce terrain et de la fausse couche spontanée fréquente à ce terme.

Le traitement des accès graves à une espèce non falciparum repose identiquement sur l'artésunate.

Tableau 5. Traitement du paludisme grave

Le traitement du paludisme grave repose par ordre de préférence sur :

1) Artésunate IV ou IM

- 2,4 mg/kg par voie intraveineuse⁽¹⁾, H0, H12, H24, H48, H72 (3 mg/kg si enfant < 20 kg)
- un relais est possible *per os* à partir du 4^e jour par un ACT (traitement complet)
- en cas de relais impossible, le traitement par artésunate peut être poursuivi jusqu'à 7 jours pleins (9 doses)
- Artésunate intrarectal (enfant < 6 ans) : 10 mg/kg par dose

2) Artéméthér IM si artésunate IV non disponible :

Adultes :

- 2 ampoules de 80 mg par voie intramusculaire le premier jour
- 1 ampoule de 80 mg les 4 jours suivants

Enfants :

- 3,2 mg/kg par voie intramusculaire, puis
- 1,6 mg/kg /jour les 4 jours suivants

3) Quinine IV (sels) si artésunate non disponible :

- surveiller la glycémie toutes les 4 à 6 heures si glycémie > 1 g/L, toutes les heures si glycémie < 1 g/L
- dose de charge⁽²⁾ : 20 mg/kg de quinine-base, diluée dans du glucosé 5 ou 10 %, 10 ml/kg (sans dépasser 500 ml)
- en perfusion intraveineuse lente de 4 heures. La dose d'attaque peut être séparée en deux et injectée dans les faces antérieures des cuisses.
- 8 à 12 heures⁽³⁾ après le début de la dose de charge : 10 mg/kg de quinine-base en perfusion lente de 4 heures
- à renouveler toutes les 8 à 12 heures⁽³⁾ jusqu'à ce que le patient puisse avaler
- puis : 8 mg/kg de quinine-base par voie orale toutes les 8 à 12 heures⁽⁴⁾
- pour une durée totale de 7 jours

Si les thérapeutiques IV sont indisponibles et dans l'attente d'un référencement vers une structure de santé mieux équipée, le traitement reposera par ordre de préférence sur :

- 1) Artésunate IM
- 2) Artésunate intrarectal (valable pour l'enfant de moins de 6 ans)
- 3) Artéméthér IM
- 4) Quinine IM
- 5) Quinine intrarectale

(1) L'artésunate, dissous dans une solution de bicarbonate, est dilué dans 5 ml de glucosé à 5 % et injecté en bolus intraveineux.

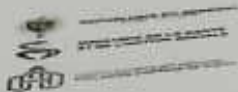
(2) Une dose de charge doit être envisagée uniquement chez l'adulte, sauf si le patient a déjà reçu de la quinine ou de la méfloquine dans les 12 heures précédentes.

(3) Préférer un intervalle de 12 heures chez l'enfant ; en Afrique, la sensibilité relativement conservée des souches à la quinine permet d'espacer les perfusions à 12 heures au lieu de 8 heures.

(4) En cas d'insuffisance rénale persistante après 48 heures, diminuer d'un tiers la dose quotidienne.

Tableau 6. Prise en charge des complications du paludisme grave

Manifestations	Prise en charge
Fièvre	Moyens physiques, paracétamol (50 mg/kg/24 heures, en trois à quatre prises)
Convulsions	Liberté des voies aériennes, décubitus latéral de sécurité Diazépam (< 3 ans : 3 à 5 mg ; 3 à 10 ans : 5 à 10 mg) injectable ou intra-rectal
Coma	Liberté des voies aériennes, décubitus latéral de sécurité Exclure d'autres causes de coma : hypoglycémie, méningite Intubation si nécessaire
Hypoglycémie	Injection intraveineuse directe d'une ampoule de glucosé à 30-50 % Puis perfusion de glucosé à 10 % : si persiste, réduire le débit de quinine



PALUDISME GRAVE

ORDONNANCE DE MISE SOUS TTT ARTHESUNATE INJECTABLE

NOM : PRENOM : POIDS :
AGE : SEXE :
TDR+ ET/OU GE+ NB : NOMBRE DE DOSE MINIMAL EST 3 DOSES
DOSE à INJECTER :

MANIFESTATIONS CLINIQUES
☐ COMA
☐ CONVULSION
☐ COLLAPSE CV
☐ HEMOGLOBINURIE MACROSCOPIQUE
☐ ICTERE
☐ PROSTRATION
☐ RESPIRATION ACIDOSIQUE
☐ OAP
☐ SAIGNEMENT SPONTANE

MANIFESTATIONS BIOLOGIQUES
☐ ANEMIE SEVERE
☐ ACIDOSE METABOLIQUE
☐ HYPOGLYCEMIE
☐ HYPERPARASITEMIE
☐ INSUFF RENALE

Paludisme GRAVE (Critères obstétricaux)

- ☐ Souffrance fœtale chronique
- ☐ Mort fœtale in-utéro
- ☐ Menace d'accouchement prématuré
- ☐ Menace d'avortement
- ☐ Vomissements incoercibles

NOMBRE DE FLACON DEMANDE :

MEDECIN TRAITANT

MAJOR DE SERVICE

TOUBA le

CHNMT/LABO/BS

EPUBLIQUE